

Trastorno Bipolar

- **Describir las manifestaciones clínicas:**
 - Condición **crónica** caracterizada por **alternancia de episodios anímicos**
 - Ánimo anormalmente elevado/expansivo/irritable
 - Autoestima **exagerada**
 - Disminución de sueño
 - Verborragia/ pensamiento acelerado
 - Participación en actividades **potencialmente riesgosas**
 - **Manía** → al menos una **semana**, impacto **significativo** laboral/social
 - **Hipomanía** → Al menos **4 días**, **no interrumpe** vida cotidiana
- **Criterios diagnósticos:**
 - **T.B. I** → Episodio de manía, con/sin depresión mayor (episodios previos)
 - **T.B. II** → Hipomanía + depresión mayor
 - **Trastorno ciclotímico** → hipomanía + síntomas depresivos leves (durante 2 años)
 - **Otros T.B. especificados** → cuadros con “rasgos” de bipolaridad
- **Perfil cognitivo:** (Funciones cognitivas afectadas)
 - **Atención** → sostenida y selectiva
 - **Funciones ejecutivas** → Planificación, secuenciación, control inhibitorio y memoria de trabajo
 - **Memoria** → Dificultades en la evocación
 - **Cognición social** → Teoría de la Mente
 - **Fallas en “auto-monitoreo”** → malos informantes (hay que acudir a familiares o personas cercanas)

Esquizofrenia

- **Describir las manifestaciones clínicas:**
 - **Afecta forma de pensar, sentir y comportarse** → **Distorsión de la realidad**
 - **Psicosis** → pérdida de contacto con la realidad
 - Ideas delirantes
 - Alucinaciones
 - Conducta y habla desorganizadas
 - Afecto aplanado
 - Déficits cognitivos
 - Impacto laboral y social
- **Criterios diagnósticos:**
 - **≥ 2 síntomas característicos** durante una parte significativa de un período de **6 meses**
 - Signos prodrómicos o atenuados de la enfermedad con deterioro social, ocupacional o de los cuidados personales evidentes durante **6 meses** que incluya **1 mes de síntomas activos**
 - Involucra un rango de **disfunciones cognitivas y emocionales** que incluyen: percepción, pensamiento inferencial, lenguaje y comunicación, automonitoreo conductual, voluntad, iniciativa, atención, entre otros

Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad

- **Describir las manifestaciones clínicas:**
 - Inatención → distracción moderada a grave, períodos de atención **breve**
 - Hiperactividad → Inquietud **motora**
 - Comportamiento impulsivo → **inestabilidad emocional** y conductas impulsivas
- **Criterios diagnósticos:**
 - 9 síntomas de déficit de atención y 9 síntomas de hiperactividad/impulsividad (el DSM V se basa en **niños**) *
 - **≥ 6** síntomas
 - **≥ 6** meses de **prevalencia** de los síntomas
 - Ser **más pronunciados** que los previstos para el nivel de desarrollo del niño
 - Nivel de ocurrencia: en **al menos 2** situaciones/lugares
 - Estar presentes **antes** de los **12 años** (al menos algunos de los síntomas)
 - Interferir con el funcionamiento en el hogar/escuela/trabajo
- **Perfil cognitivo:**
 - **Atención** → distracciones queja más frecuente
 - **Control inhibitorio** → Falla en autorregulación (interrupciones en conversaciones, actuar sin considerar consecuencias futuras- impulsividad)
 - **Cognición social** → Dificultad en interacción social, déficit en ToM (Lectura de ojos y Faux pas). Alta demanda atencional impacta negativamente en procesamiento de estímulos emocionales. Dificultades en atribución de emociones
 - **Otras funciones ejecutivas** → Memoria de trabajo, bajo rendimiento en planificación y alternancia entre categorías
 - **Memoria** → Dif en recuperación y codificación de información por fallas atencionales y en el uso de estrategias para organizar información
 - **VPI y Velocidad motora** → alta demanda cognitiva = + tiempo de reacción
 - **Inteligencia** → déficit en velocidad perceptivo-motora y aritmética

-
- **Perfil cognitivo:**
 - **Atención y vigilancia** → Dificultad para seguir conversaciones, incapacidad para seguir instrucciones, lecturas o ver televisión
 - **Memoria verbal y visual** → déficit en **aprendizaje** más que en retención
 - **Razonamiento y resolución de problemas** → dificultad para adaptarse al mundo cambiante
 - **Velocidad de procesamiento** → Dificultad en capacidad de mantenerse al día con tareas
 - **Memoria de trabajo** → Componente central del deterioro cognitivo característico del trastorno
 - **Cognición social** → Pobre desempeño en ToM. Déficit en test de percepción facial de emociones

Síntomas TDAH en adultos:

Tabla 3. Manifestaciones relacionadas con el TDAH en el adulto

Hiperactividad	Sensación interna de inquietud
	Dificultad para relajarse
	Avances y retrocesos en actividades
	Hablar en exceso, muy rápido y con un volumen alto
	Dificultad para tolerar trabajos sedentarios (por ejemplo, trabajo de oficina) debido a la necesidad de moverse en exceso
	Incapacidad para permanecer quieto, con tensión muscular incrementada
	Movimientos nerviosos, <i>fidgeting</i> (inquietud), <i>rocking</i> (vaivén), y balancearse en las sillas
	Tropezar o llevarse cosas por delante debido a movimientos excesivos
Desatención	Incremento de movimientos durante el sueño
	Olvidos
	Distractibilidad
	Presentación caótica
	Dificultad para organizarse
	Dificultad para escuchar
	Dificultad para llegar puntualmente (llegadas muy tardías o muy tempranas)
	Perderse en detalles menores
	Foco excesivo (hiperfoco) temporal en tareas de interés, con dificultad para redirigir la atención cuando es requerido o en actividades cotidianas esenciales
	Dudas y dificultades para tomar decisiones o resolver problemas
	Dificultad para iniciar o finalizar tareas
	<i>Mind wandering</i> (divague de la mente)
	Mente inquieta
	Pensamientos espontáneos no relacionados, constantes, saltando de uno a otro
	Pensamientos múltiples al mismo tiempo
	Pensamiento asociativo
Impulsividad	Dificultad para esperar su turno, asociado a irritabilidad
	Actuar sin pensar
	Hacer comentarios inadecuados que causan malestar a otros
	Búsqueda de riesgos y emociones fuertes
	Iniciar vínculos demasiado rápidamente
	Incapacidad para posponer la gratificación
	Gastos excesivos o inadecuados
	Abandonar o renunciar a los trabajos frecuentemente
Desregulación emocional	Comportamientos por atracón
	Labilidad emocional
	Baja tolerancia a la frustración
	Impulsividad emocional
	Irritabilidad
	Estallidos de enojo bruscos
	Incremento de síntomas premenstruales

Nota: Tomado de “Updated European Consensus Statement on diagnosis and treatment of adult ADHD”, de J. Kooij et al., 2019, *European Psychiatry*, 56(1), p. 18.

Síntomas TDAH en niños:

Tabla 4. Criterios de síntomas del TDAH según el DSM-5

Criterio A1		Criterio A2
Síntomas de falta de atención		Síntomas hiperactivos-impulsivos
1	A menudo no presta mucha atención a los detalles o comete errores por descuido en el trabajo escolar	A menudo se mueve inquieto con las manos o los pies o se retuerce en el asiento
2	A menudo tiene dificultad para mantener la atención en tareas o actividades de juego	A menudo deja su asiento en el aula cuando se espera que permanezca sentado
3	A menudo parece no escuchar cuando se le habla directamente	A menudo corre o trepa excesivamente en situaciones en las que no es apropiado
4	A menudo no sigue las instrucciones y no termina el trabajo escolar	A menudo tiene dificultad para jugar o realizar actividades de ocio tranquilamente
5	A menudo tiene dificultades para organizar tareas y actividades	A menudo está “en movimiento” o actúa como si estuviera “impulsado por un motor”
6	A menudo evita, no le gustan o se involucra de mala gana en tareas que requieren un esfuerzo mental sostenido	A menudo habla excesivamente
7	A menudo pierde cosas necesarias para las actividades (por ejemplo, tareas escolares, lápices o libros)	A menudo deja escapar respuestas a las preguntas antes de haberlas completado
8	A menudo se distrae con estímulos extraños	A menudo tiene dificultades para esperar su turno
9	A menudo es olvidadizo en las actividades diarias	A menudo interrumpe o se entromete (por ejemplo, se entromete en conversaciones y/o juegos)

Depresión

- **Describir las manifestaciones clínicas:**
 - **Tristeza intensa** que interfiere en el funcionamiento **diario**
 - **Pérdida de interés** en actividades/relaciones
- **Criterios diagnósticos:**
 - Estado de ánimo depresivo la mayor parte del **día**
 - Marcada disminución del **interés** o **placer** en todas/casi todas las actividades la mayor parte del **día**
 - Aumento/pérdida **significativa (>5%)** de peso/apetito
 - Insomnio/hipersomnia
 - Agitación/retardo psicomotor observado por **otros**
 - Sentimientos de inutilidad, culpa excesiva/inapropiada
 - Capacidad disminuida para pensar/concentrarse o indecisión
 - Pensamientos recurrentes de muerte/suicidio, intento de suicidio o un **plan específico** para suicidarse
- **Perfil cognitivo:**
 - Perfil cognitivo **temporal**
 - Déficit en tareas de esfuerzo → Motivación y energía mental influyen más que un daño cerebral
 - **Memoria:** Tendencia de recordar información negativa. **Priming de palabras negativa.** Almacenamiento conservado, pero déficit en adquisición y evocación
 - **Atención:** Déficit en velocidad de procesamiento